3.哮喘急性发作期的治疗

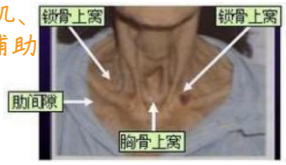
轻度	中度	重度	危重度
步行或上楼时气短	稍活动气短	端坐呼吸	意识障碍
讲话正常	讲话中断	单字表达	不能讲话
散在哮鸣音	**弥漫响亮哮鸣音，可三凹征和奇脉**	**弥漫响亮哮鸣音，明显三凹征和奇脉，R＞30、PEF＜60%、心率＞120** 3 6 12	**可沉默肺（哮鸣音减弱甚至消失），脉率慢或不规则、血压↓，胸腹矛盾运动/反常运动**
气道严重闭塞→患者通过用力吸气试图克服气道阻塞→兴奋交感神经(交感神经舒张气道)→大汗→需补液	天天师兄	**严重哮喘急性发作治疗**：呼吸肌极度衰弱 ①**持续吸入 SABA**（迅速缓解症状的首选）+SAMA 等 （急性发作先舒张、长期控制激素强）起效慢不良反应大 ②**尽早静脉用氢化可的松或甲泼尼龙**（不用地塞米松）、茶碱 ③吸氧、补液（VS ARDS 限液）、**pH＜7.2 可补碱** ④经治疗后 $PaCO_2$≥45、呼吸肌疲劳（胸腹矛盾运动）或意识障碍（危重度）→机械通气（**意识障碍需有创机械通气**-气管插管或切开）	

《诊断学》：

①三凹征（胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙明显凹陷）：胸腔负压明显增大

主要见于大气道阻塞如喉炎、气管异物（吸气极度困难）

用力吸气:膈肌、肋间外肌、胸锁乳突肌、斜角肌(辅助吸气肌)



气道阻力既是吸气阻力又是呼气阻力

气道梗阻加重更加用力吸气→胸腔负压↑→肺血管扩张→从肺循环回左心房血↓,左心室血液↓,搏出量↓→脉搏减弱/消失

②**奇脉/吸停脉**（吸气时脉搏明显减弱或消失）：

主要见于严重的右心衰、心包积液（心脏压塞）、缩窄性心包炎、支气管哮喘、COPD、胸膜疾病（大量胸腔积液、张力性气胸）C 魔小说包邮 严重的

张力性气胸-破口为活瓣,气体只进不出导致胸膜腔高压

肺大疱破裂

注意：限制性心肌病（心内膜及心内膜下心肌纤维化）、自发性气胸没有奇脉

缩窄性心包炎:极度吸气→肺血管扩张→回左心血↓ ┐
极度吸气→胸腔负压↑(又吸气又吸血↑)→回右心血↑→室间隔向左推 ┘→左室血↓↓→搏出量↓→奇脉/吸停脉

限制性心肌病:心内膜纤维化(封住室间隔),无摆动,故无奇脉/吸停脉

真题解析·支气管哮喘

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2016N65 A 支气管哮喘急性发作首选的治疗方法是

A.静脉注射氨茶碱 急性发作先舒张

B.雾化吸入异丙托溴铵

C.雾化吸入沙丁胺醇

D.静脉使用糖皮质激素

2.2020N44 A 男性，21 岁。自幼对花粉过敏，多次接触花粉后出现荨麻疹及喘息。此次再次接触花粉后喘息 6 小时。查体：双肺可闻及散在哮鸣音，此时不宜进行的检查是

A.血嗜酸性粒细胞计数

B.支气管舒张试验

C.支气管激发试验

D.胸部 X 线片

答案:1-2 C C